

国際的な健康課題とジェンダー平等及び ユニバーサル・ヘルス・カバレッジの達成

名古屋市立大学 公衆衛生学分野
中川弘子

- 途上国で暮らす人々は、世界人口のどのくらいを占めるでしょうか？

A. 約15%

B. 約40%

C. 約80%

- 途上国の中でも、低所得国で暮らす人々は、世界でどのくらいいるのでしょうか？

A. 50%

B. 30%

C. 9%

- 世界人口のうち、極度の貧困にある人の割合は、過去20年間にどう変わったでしょうか？

- A. 約2倍になった
- B. 半分になった
- C. あまり変わっていない

- 現在、低所得国に暮らす女子の何割が、初等教育を終了するでしょうか？

A. 20%

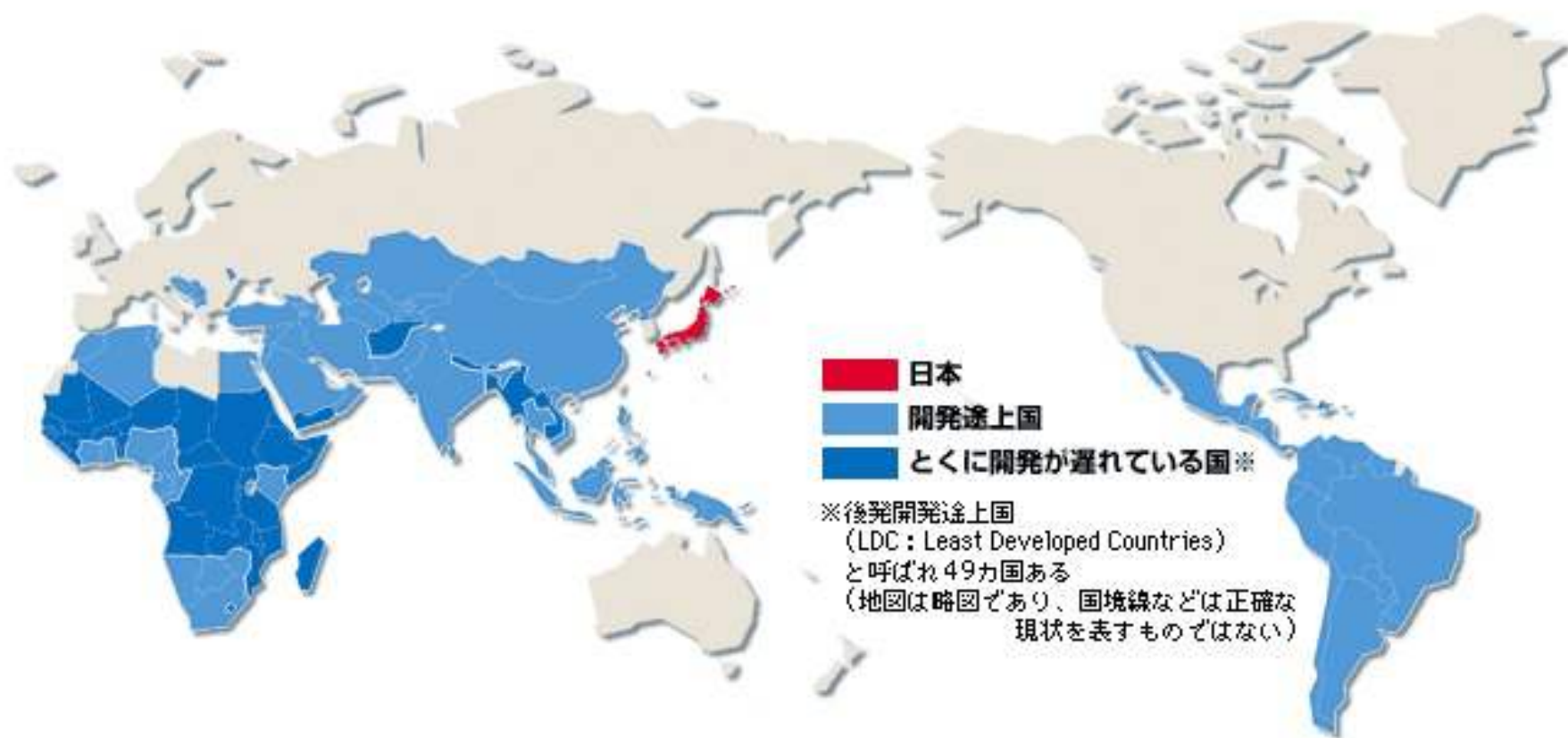
B. 40%

C. 60%

発展途上国とは？

- 一般に人口一人当たりの国民総所得（GNI）が低く、産業構造が一次産業に偏った国を発展途上国と呼ぶ。
- 経済発展や開発水準が先進国と比べて低く、経済成長の途上にある国を指す。
- 一般的には、経済協力開発機構（OECD）の開発援助委員会（DAC）が作成する援助リストに載っている国を指す。
- 世界銀行による分類では、途上国は「低所得国」「下位中所得国」「上位中所得国」の3つに分かれている。

開発途上国



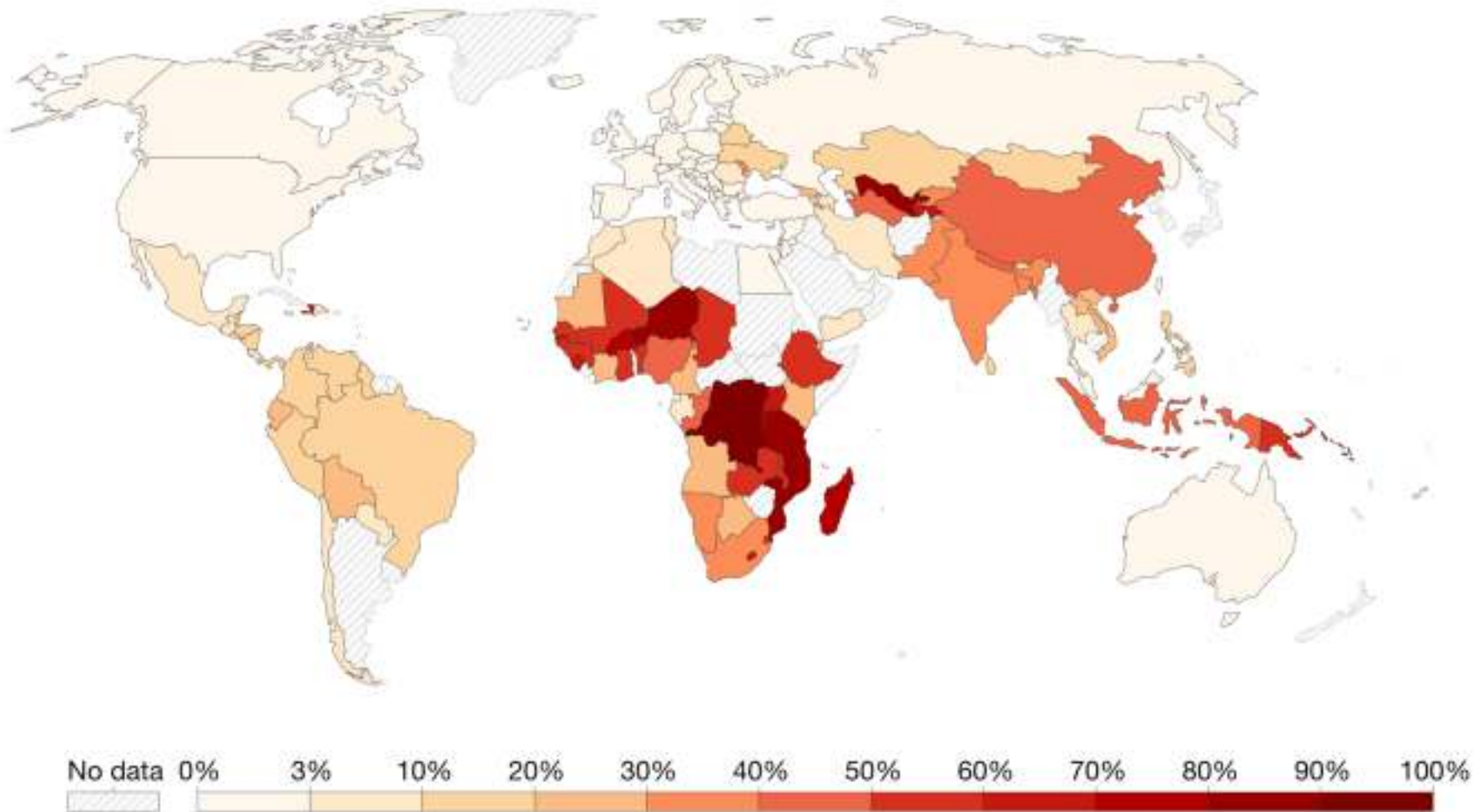
先進国と途上国

	高所得国 13 億人	新興国 58 億人		
		中所得国 50 億人		低所得国 8 億人
		上位中所得国 24 億人	下位中所得国 26 億人	
所得水準（一人当たり GNI） 2013 年	12,746 ドル以上	4,126 ドル～12,745 ドル	1,046 ドル～4,125 ドル	1,045 ドル以下
国・地域の総数	76	55	50	41
主な構成国・地域	G7 諸国 ユーロ圏諸国 韓国 台湾 香港 シンガポール ブルネイ オーストラリア ニュージーランド ノルウェー スイス チェコ ポーランド ロシア チリ プエルトリコ ウルグアイ バーレーン イスラエル クウェート オマーン カタール サウジ UAE 等	中国 マレーシア タイ トルコ ベラルーシ ブルガリア カザフスタン ルーマニア アルゼンチン ブラジル コロンビア ジャマイカ メキシコ ペルー ベネズエラ アルジェリア イラン イラク ヨルダン リビア チュニジア アンゴラ ボツワナ モーリシャス 南アフリカ共和国 等	インド インドネシア ラオス モンゴル パキスタン フィリピン ベトナム ウクライナ ウズベキスタン ボリビア ホンジュラス パラグアイ エジプト モロッコ カメルーン コンゴ共和国 ガーナ ナイジェリア スーダン ザンビア 等	バングラディシュ カンボジア ミャンマー ネパール タジキスタン コンゴ民主共和国 エチオピア ケニア リベリア マダガスカル モザンビーク ルワンダ タンザニア ウガンダ ジンバブエ 等

資料：世銀「WDI」から作成。

絶対的貧困に暮らす人口の割合（2000年）

絶対的貧困とは、一人当たりの家計消費が1日1.25ドル未満で生活することと定義されていた

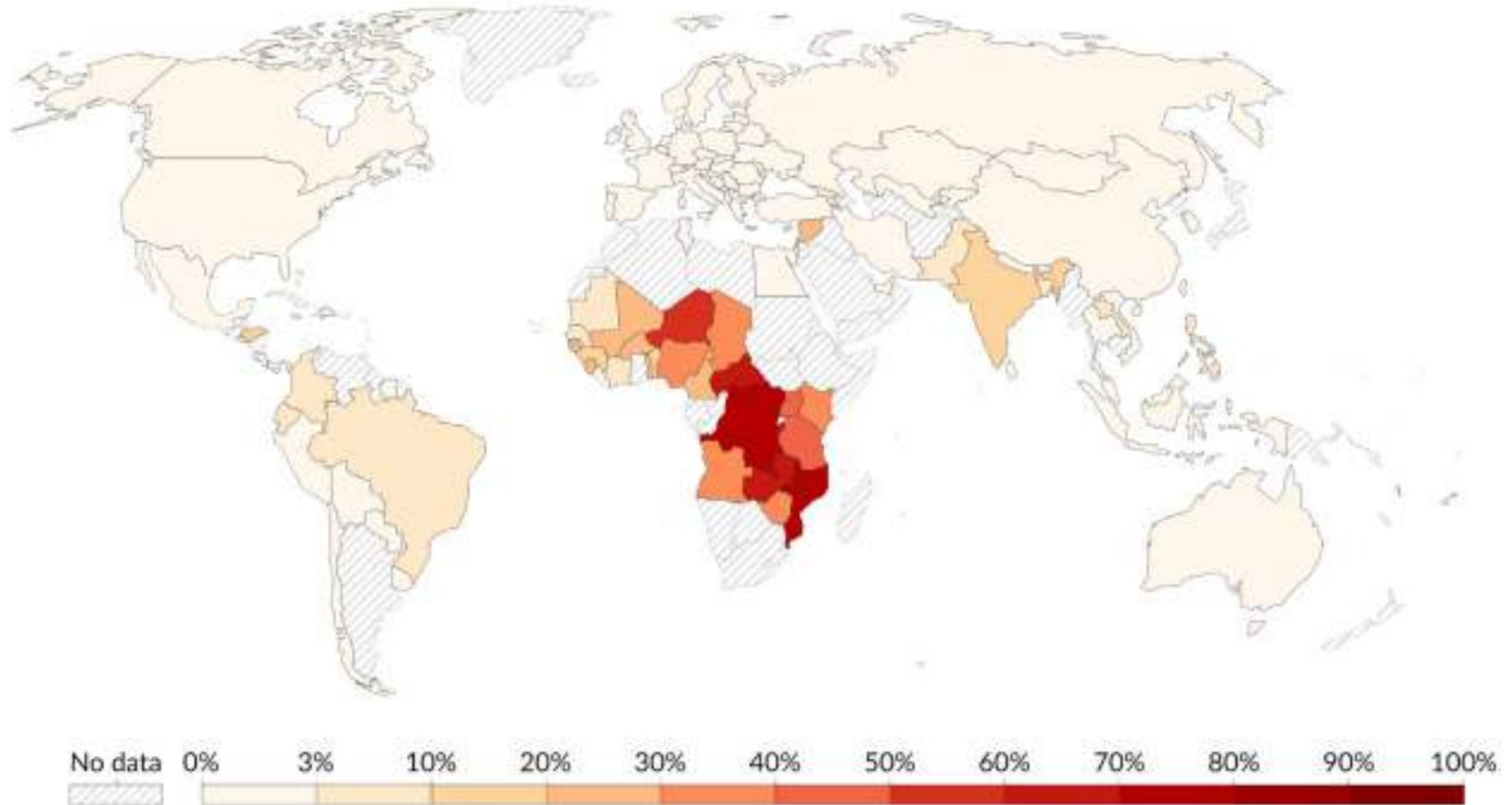


Source: World Bank Poverty and Inequality Platform

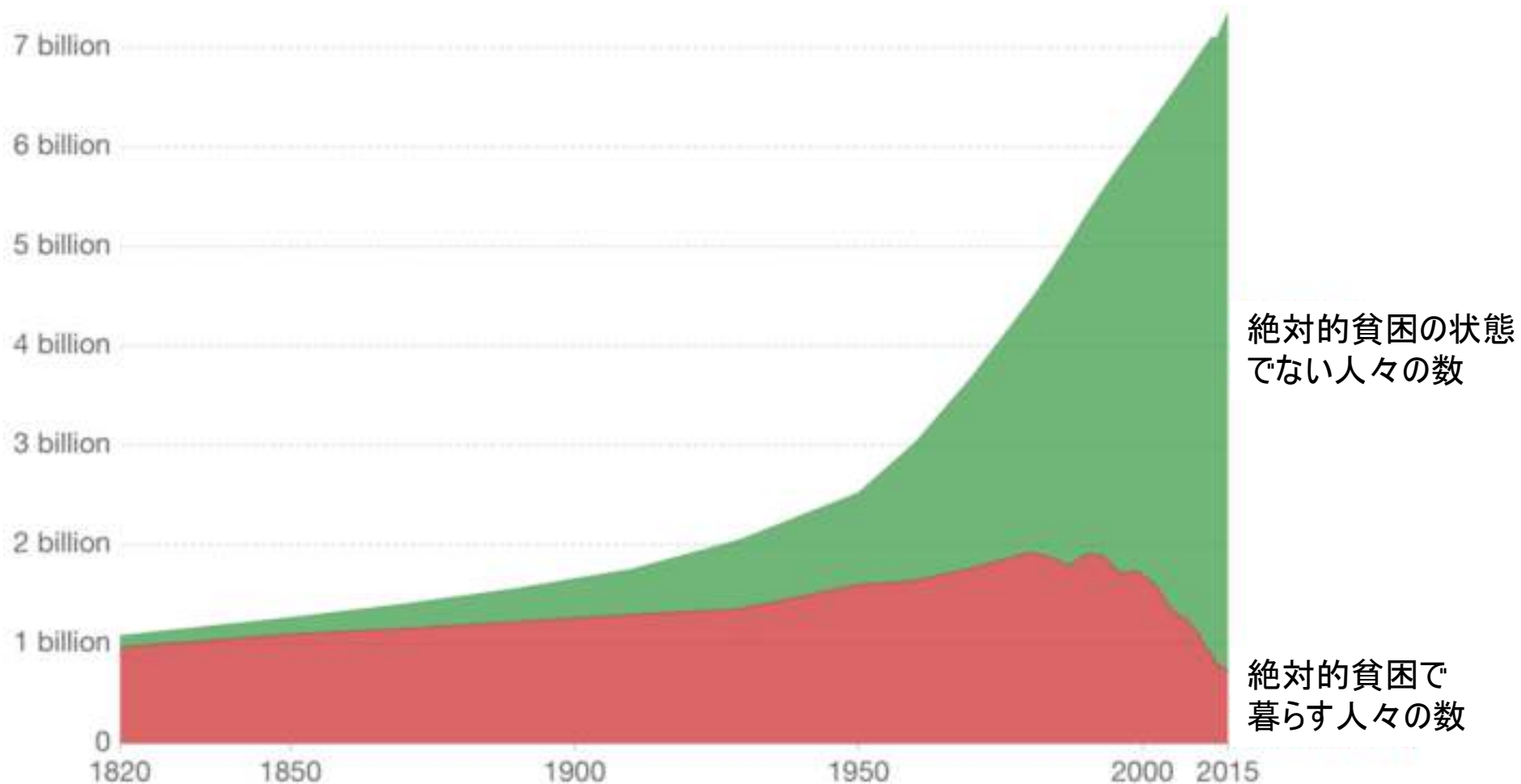
OurWorldInData.org/poverty •

絶対的貧困に暮らす人口の割合（2023年）

絶対的貧困とは、一人当たりの家計消費が1日2.15ドル未満で生活することと定義されている



絶対的貧困に暮らす世界の人々の数（1820年から2015年）



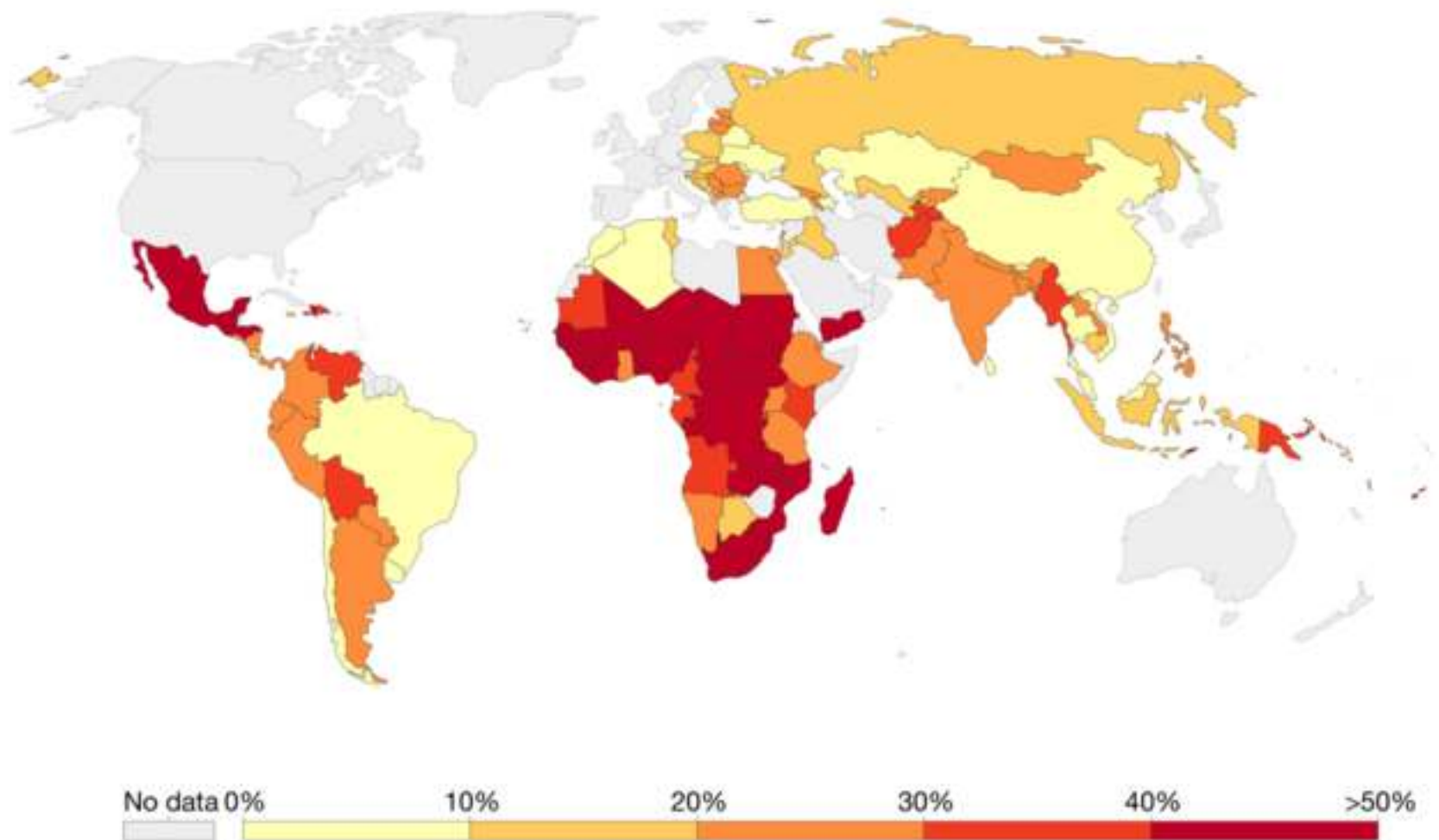
Source: Ravallion (2016) updated with World Bank (2019)

Note: See [OurWorldInData.org/extreme-history-methods](https://ourworldindata.org/extreme-history-methods) for the strengths and limitations of this data and how historians arrive at these estimates.

[OurWorldInData.org/extreme-poverty/](https://ourworldindata.org/extreme-poverty/) • CC BY

国の貧困ラインで貧困状態にある人口の割合 (2017)

相対的貧困: その国の文化水準、生活水準と比べて困窮した状態



Source: World Bank

CC BY

Our World in Data Retrieved from: <https://ourworldindata.org/grapher/share-of-population-living-in-poverty-by-national-poverty-line> (Accessed on 18 May 2020)

国連ミレニアム開発目標

(Millennium Development Goals : MDGs)

目標と主なターゲット



目標1：極度の貧困と飢餓の撲滅

- 1日1.25ドル未満で生活する人口の割合を半減させる
- 飢餓に苦しむ人口の割合を半減させる



目標2：初等教育の完全普及の達成

- すべての子どもが男女の区別なく初等教育の全課程を修了できるようにする



目標3：ジェンダー平等推進と女性の地位向上

- すべての教育レベルにおける男女格差を解消する



目標4：乳幼児死亡率の削減

- 5歳未満児の死亡率を3分の1に削減する



目標5：妊産婦の健康の改善

- 妊産婦の死亡率を4分の1に削減する



目標6：HIV／エイズ、マラリア、その他の疾病の蔓延の防止

- HIV／エイズの蔓延を阻止し、その後減少させる



目標7：環境の持続可能性確保

- 安全な飲料水と衛生施設を利用できない人口の割合を半減させる



目標8：開発のためのグローバルなパートナーシップの推進

- 民間部門と協力し、情報・通信分野の新技术による利益が得られるようにする

* ロゴは「特定非営利活動法人 ほっとけない 世界のまずしさ」が作成したもの。

達成状況

目標1 極度の貧困と飢餓の撲滅

- 貧困に関するターゲット(極度の貧困人口の割合を1990年比で半減)は2010年に達成。2015年には1/3に(中国の発展の影響大)
- サブサハラ・アフリカ人口の41%は依然極度の貧困層
- 開発途上地域における栄養不良人口の割合はほぼ半減

1990-92年:23.3% → 2014-16年:12.9%

※ただし、今なお約8億人(世界人口の9人に1人)が栄養不良状態。更なる努力が必要

一日1.25ドル未満で暮らす人々の割合		
	1990年	2015年
世界全体	36% (19億人)	12% (8.4億人)
開発途上地域	47%	14%



Retrieved from https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/17/rls_0909h.html
(Accessed on 22 April 2025)

The vulture and the little girl, 1993. Original title: Struggling Girl.
Taken by Kevin Carter.

目標2 初等教育の完全普及の達成

目標3 ジェンダー平等推進と 女性の地位向上

- 就学率及び若年層の識字率は向上するも、全ての児童の初等教育修了は実現せず
- 開発途上地域総体として見た場合、全ての教育レベルにおける男女格差が解消
- 1995-2015年で、世界の女性議員比率は倍増
※ただし、総数は男性議員の1/5にすぎない



出典: Charity Platform

目標4 乳幼児死亡率の削減

目標5 妊産婦の健康の改善

目標6 HIV/エイズ、マラリア、その他の疾病の蔓延の防止



出典：国境なき医師団

- 世界の5歳未満児死亡率は53%減少，ターゲット (1990年比で1/3まで削減)達成までは至らず
- 世界の妊産婦死亡率は45%減少，ターゲット (1990年比で1/4まで削減)達成までは至らず
- 開発途上地域の妊産婦のうち望ましい妊産婦検診を受けているのは2014年は52%、普遍的なリプロダクティブ・ヘルスへのアクセスが達成されたとはいえない
- 2000-2013年，世界のHIV/エイズの感染は40%減少。2000-2015年で、620万人以上の命がマラリア対策により，2000-2013年で、3700万人の命が結核対策により救われたと推定される

2015年 持続可能な開発サミット



国際連合広報局

2015年9月 「国連持続可能な開発サミット」新たな持続可能な開発アジェンダを採択
17の「持続可能な開発目標(SDGs)」は共有する人間性のビジョン、MDGsに代わる指標

持続可能な開発目標(SDGs)

平成30年度から
医師国家試験の
問題基準

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

世界を変えるための17の目標

2030年までの
新たな開発目
標



1 貧困を
なくそう



© UNDP Guatemala / Caroline Trülmann

あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ

2 飢餓を
ゼロに



飢餓・栄養失調の解消
肥満対策
2050年までに増加する20億人
の食料供給



飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに、持続可能な農業を推進する

3 すべての人に
健康と福祉を



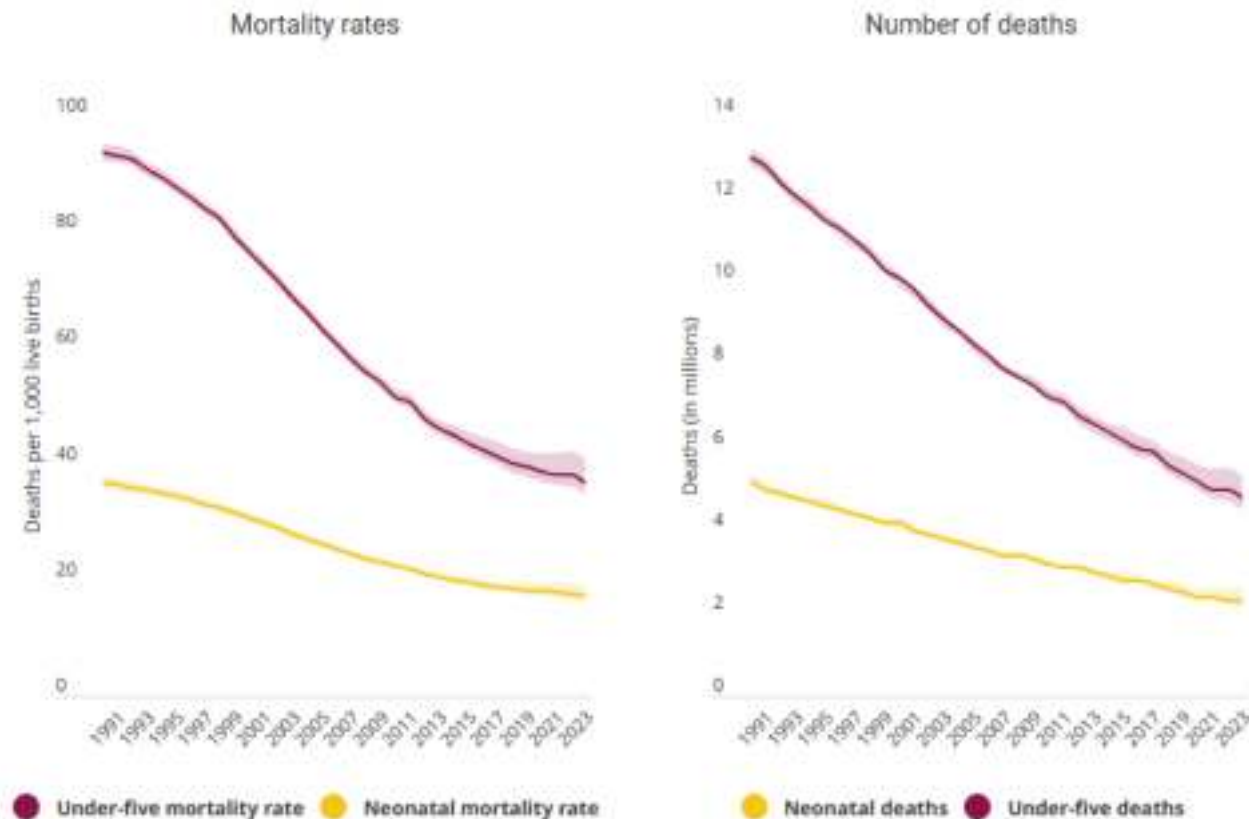
- ・世界の妊産婦死亡率、5歳未満死亡率減少
- ・エイズ、結核、マラリアおよび顧みられない熱帯病を根絶
- ・世界の道路交通事故による死傷者を半減
- ・タバコの規制、薬物乱用の防止・治療
- ・ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)を達成する。

© UNDP EGIKI/PIROZZI, AGIP/PIROZZI

あらゆる年齢のすべての人の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

世界の乳幼児死亡率の推移(1990-2023)

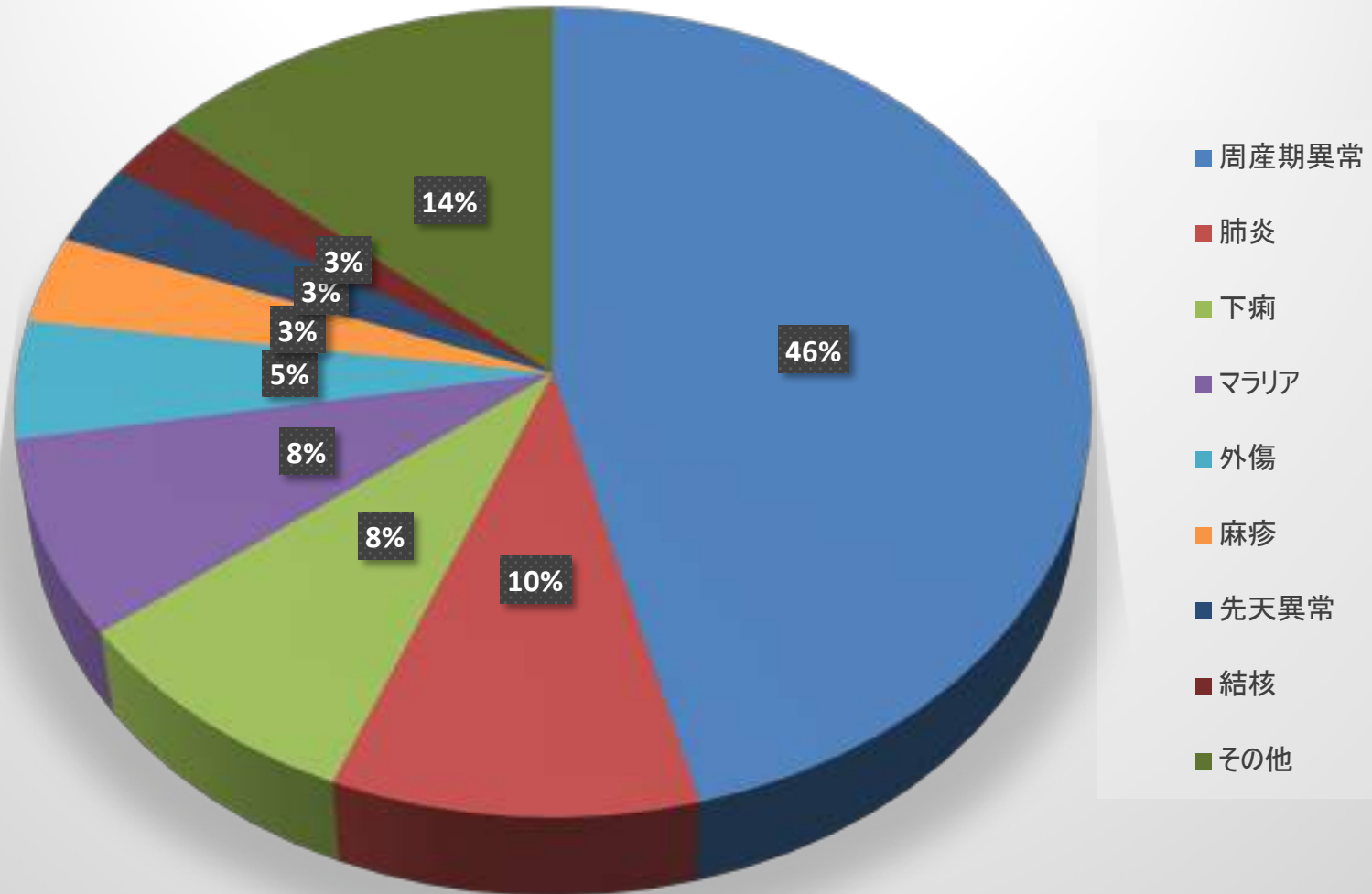
Global mortality rates and number of deaths by age, 1990-2023



Note: All figures are based on unrounded numbers. The solid line represents the median estimate and the shaded area represents the 90 per cent uncertainty bound around the median value.

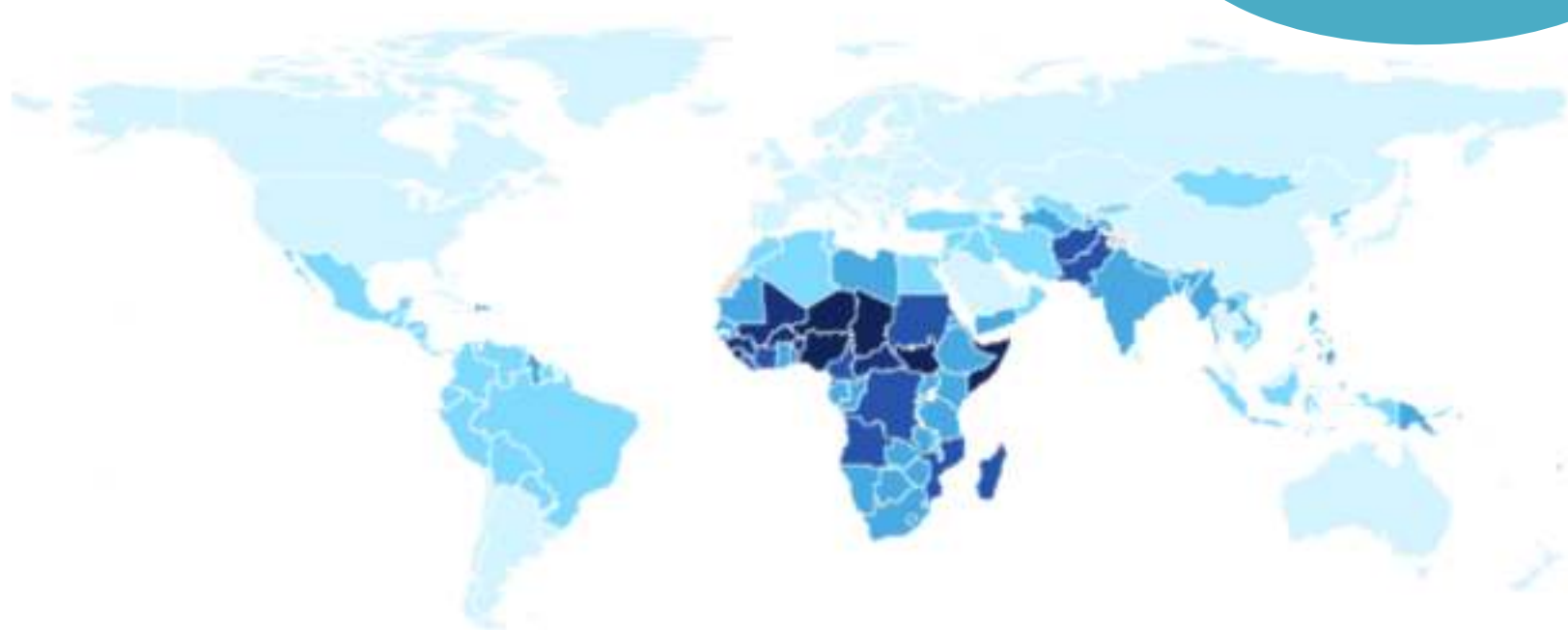
Source: United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (UN IGME), 2025.

世界の5歳未満児死亡死因(2019)



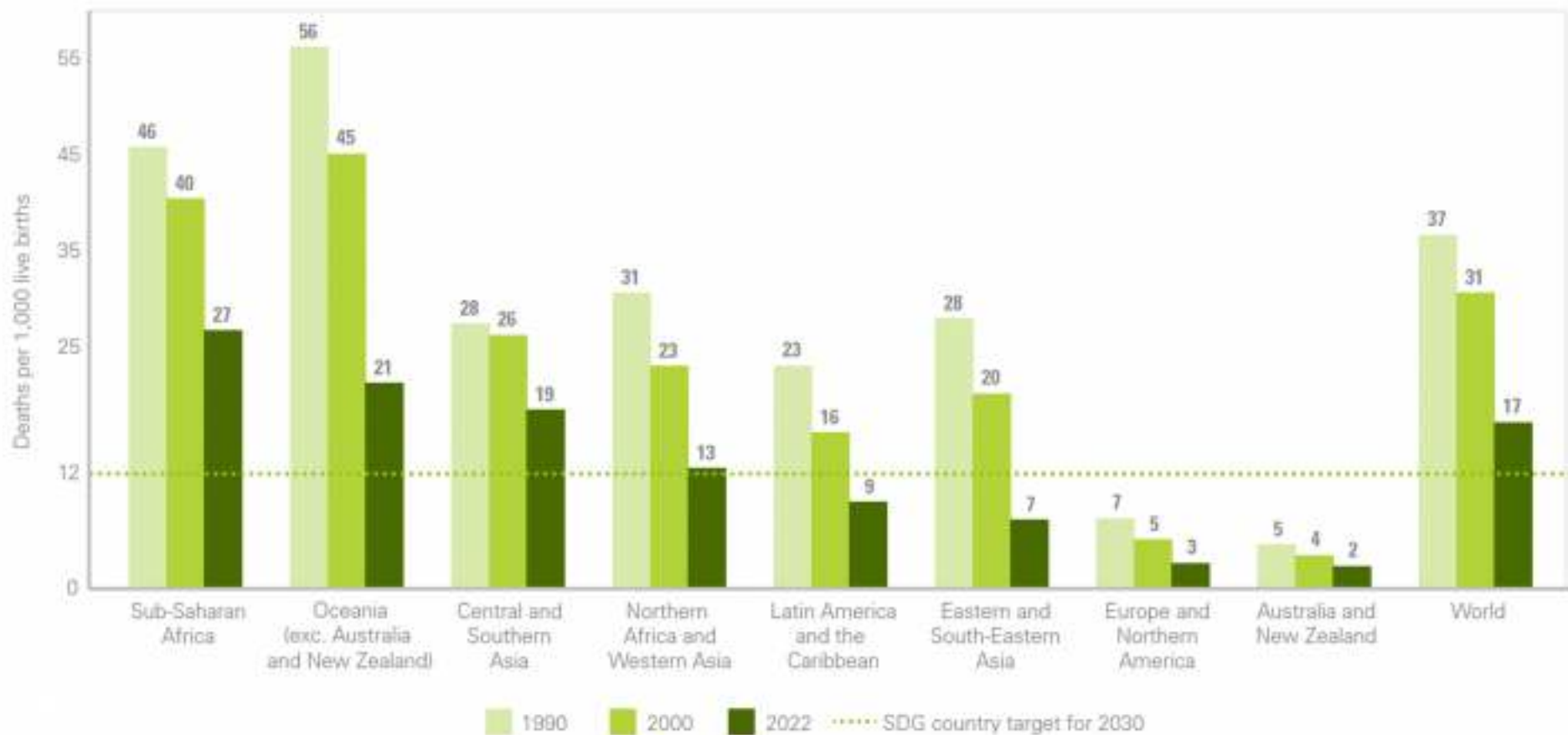
5歳未満児死亡率(出生1,000人あたり/2023年)

日本の5歳未満
死亡率は？



● ≤10 ● 10 to 25 ● 25 to 50 ● 50 to 75 ● 75 to 100 ● >100

5歳未満児死亡率の推移

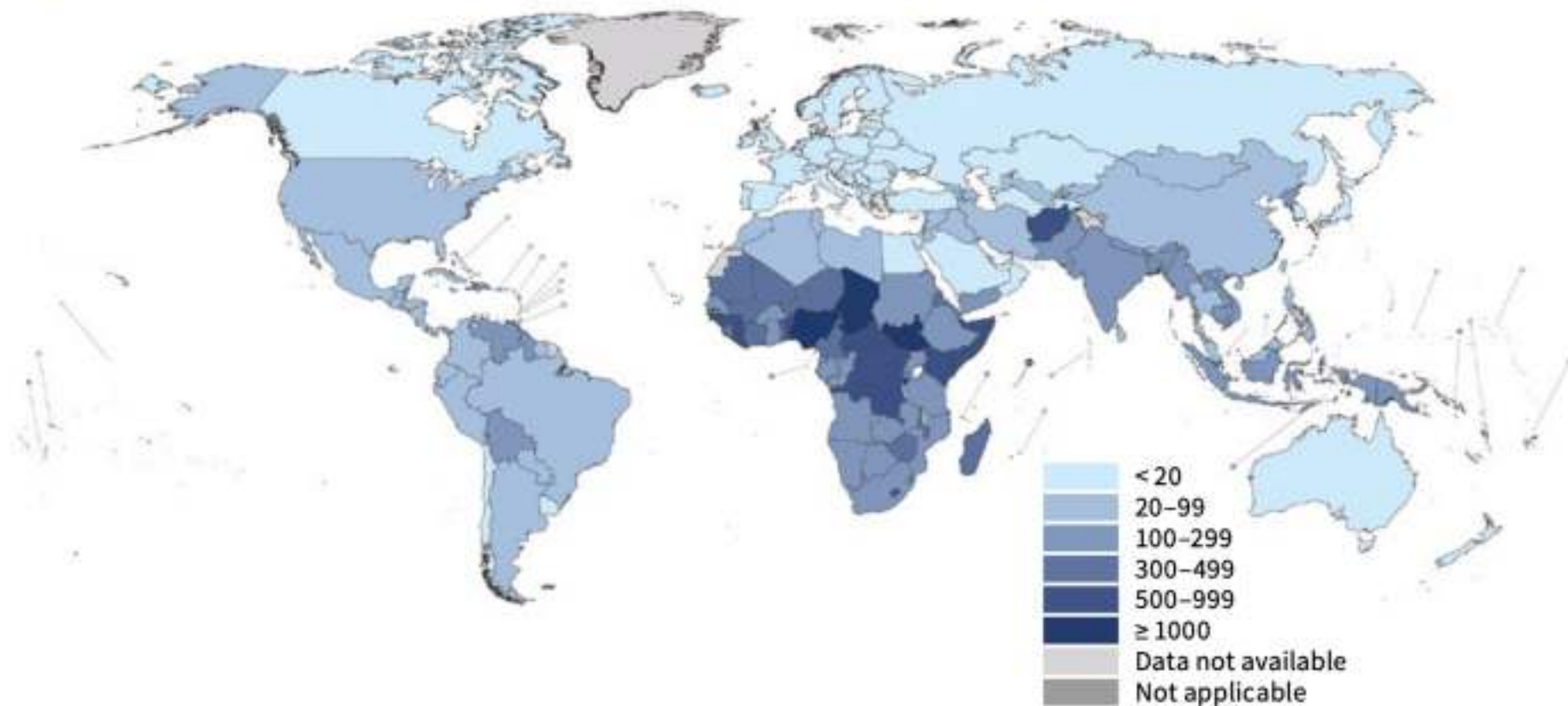


2000-2023年でどのくらい 5歳未満児死亡率が減少したのか？



世界の妊産婦死亡率(2020)

Fig. 4.1 Maternal mortality ratio (MMR) estimates, by country, 2020



妊産婦死亡率が高い理由

〈妊産婦死亡率が高い理由〉

- ・妊娠・出産時の合併症
- ・栄養不良
- ・エイズを含む既存の疾患
- ・医療ケアを受けられない
(受けない) こと
- ・医療施設整備の遅れ
- ・医薬品不足
- ・安全な出産のための知識不足
- ・医療従事者の不足

〈妊産婦が医療ケアを受けられない理由〉

- ・コストがかかる (貧しくて交通費と治療費が支払えない)
- ・医療施設が近くにない
- ・情報アクセスの不足
(文字が読めず正しい知識を持てない、言語の壁により正しい医療知識が伝わらない)
- ・専門医、看護師、その他適正な知識を有する医療従事者が少ない
- ・医療スタッフの態度の悪さ
(文化的・民族的な差別／迫害、人手不足)

世界の主な死因(2019年)

順位	先進国	低・中所得国
1	虚血性心疾患	虚血性心疾患
2	認知症	脳卒中
3	脳卒中	新生児期合併症
4	肺がん	慢性閉塞性肺疾患
5	慢性閉塞性肺疾患	下気道感染症
6	下気道感染症	下痢症
7	大腸がん	結核
8	慢性腎不全	肝硬変
9	その他の心血管系、循環器系疾患	糖尿病
10	糖尿病	交通外傷

発展途上国で感染症が流行する要因

経済的に貧しい

- ・ 慢性的な栄養不良 まんせいてき
- ・ 不衛生な環境 かんきょう
- ・ 薬が買えない
- ・ 医療が受けられない い りょう



医療整備の遅れ い りょうせいび おく

- ・ 予防接種が受けられない
- ・ 適切な治療が受けられない
- ・ 医療施設や医療従事者が少ない い りょうし せつ い りょうじゅう じしや



知識不足

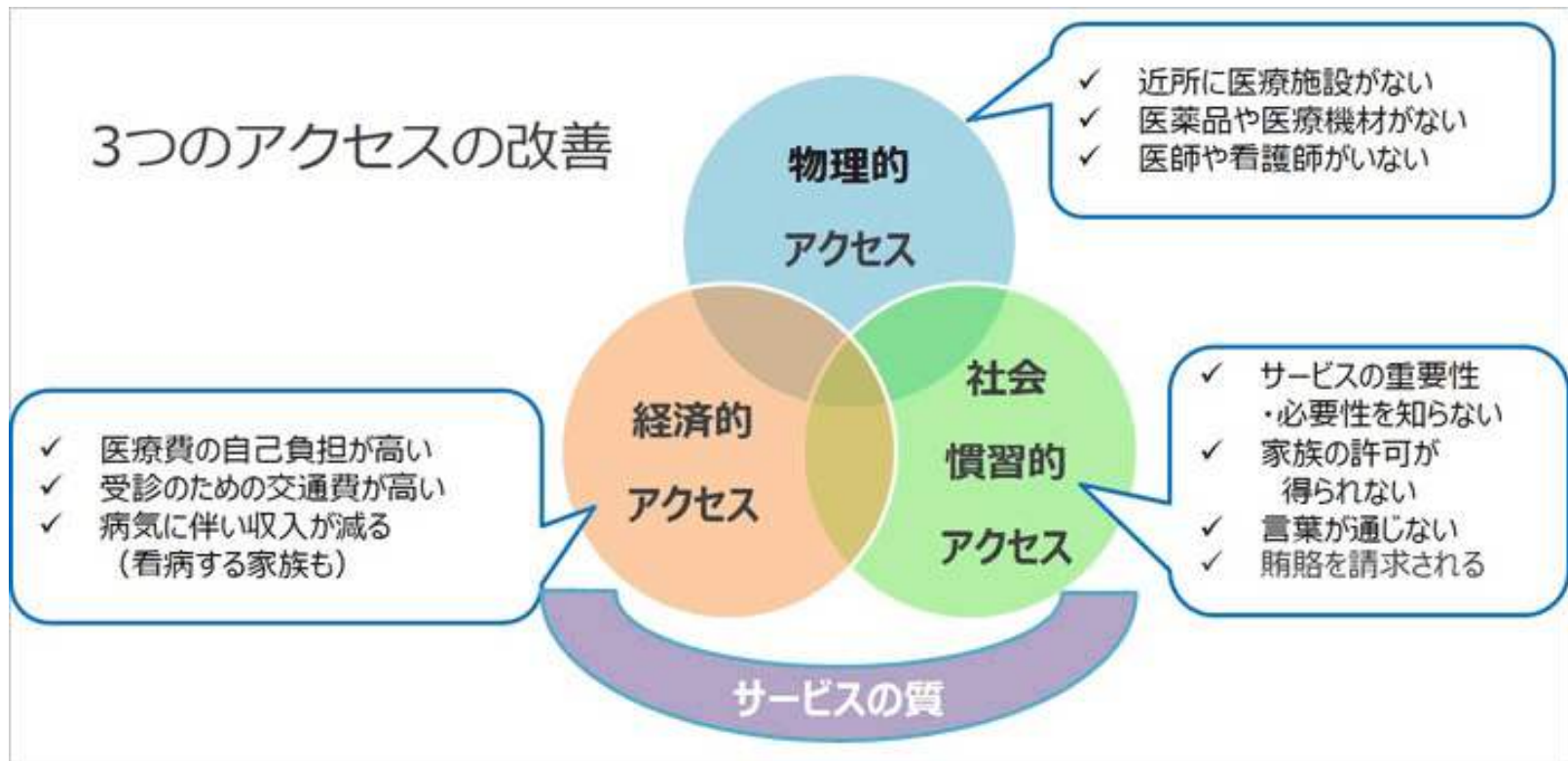
- ・ 衛生や予防についての知識・情報が少ない
- ・ 病気や予防方法などを知る機会に乏しい とほ



ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)達成

Universal Health Coverage (UHC)

「すべての人々が基礎的な保健医療サービスを、
必要なときに、負担可能な費用で享受できる状態」



4

質の高い教育を
みんなに



教育へのアクセス拡大
就学率、識字率向上
教育での男女平等

© UNDP Pakistan / Mian Khirshee

すべての人に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する

識字率

LITERACY

The adult literacy rate has risen to **86%** from **76%** in 1990.

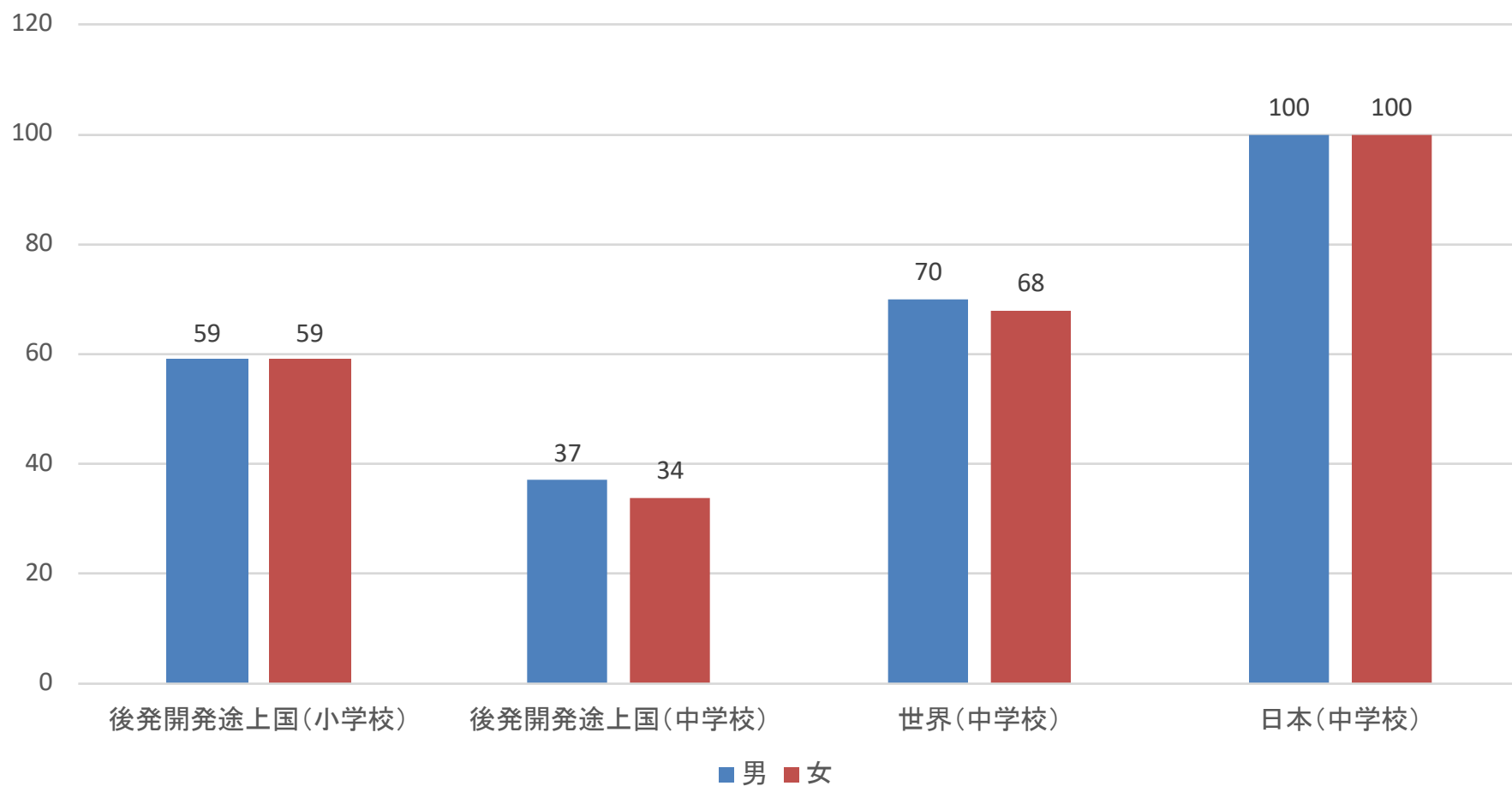


But women account for **two-thirds** of the world's illiterate.

ADULT LITERACY RATE, 2019



義務教育の修了率(%)



ジェンダーとは？

ジェンダー...社会的・文化的に形成された性別のこと

「女の子だから」「男の子だから」

「男性はこうあるべき、女性はこうあるべき」



「男性は青、女性はピンク」

「外で働くのは男性で、家のことをするのは女性」



5

ジェンダー平等を
実現しよう



女性や女児に対する差別の撤廃

人身売買や性的搾取など、あらゆる形態の暴力の排除

未成年者の結婚、強制結婚や女性器切除など有害な慣行の撤廃

無報酬の育児・介護や家事労働を認識・評価する

政治、経済、公共分野での意思決定において、

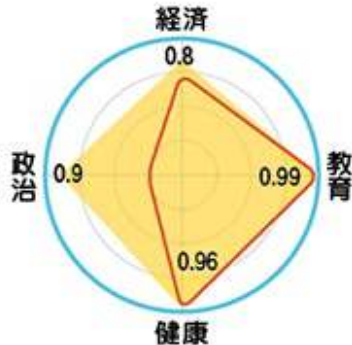
女性の参画と平等なリーダーシップの機会の確保

ジェンダーギャップ指数

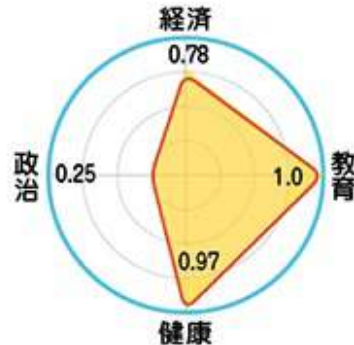
世界でみる日本の男女平等の度合い(ジェンダーギャップ指数)

日本**125位**/146カ国

1位 アイスランド



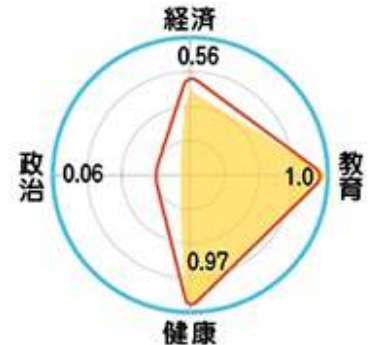
43位 アメリカ



105位 韓国



125位 日本



■ その国のスコア
— 世界の平均スコア

1に近づくほど男女平等を示している
(調査対象は146カ国)

日本のジェンダー問題

- 教育格差
- 経済格差
- 政治格差
- 家事・育児格差



日本のジェンダー問題「家事・育児格差」

図表 2-2 6歳未満の子供を持つ夫婦の家事・育児関連時間（週全体平均）（1日当たり、国際比較）



6

安全な水とトイレ
を世界中に



安全な水へ30分以内にアクセス
手洗いの普及
下水道の普及



© UNDP Afghanistan

すべての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する

国際協力の仕組み

- 二国間援助
- 国際機関

[国際連合、国際開発金融機関、IOM(国際移住機関)、
世界エイズ・マラリア・結核基金、赤十字国際委員会、etc..]

- 国際的基金(世界基金、GAVI、ゲイツ財団)
- 非政府組織(NGO)
- 民間基金

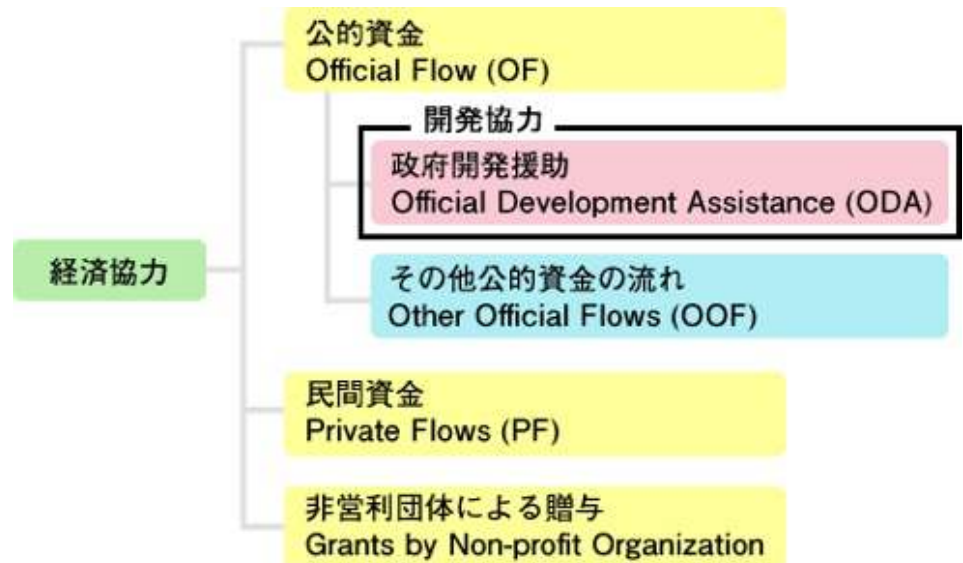
ODAとは？

2023年実績
19億6,000万ドル
世界第3位

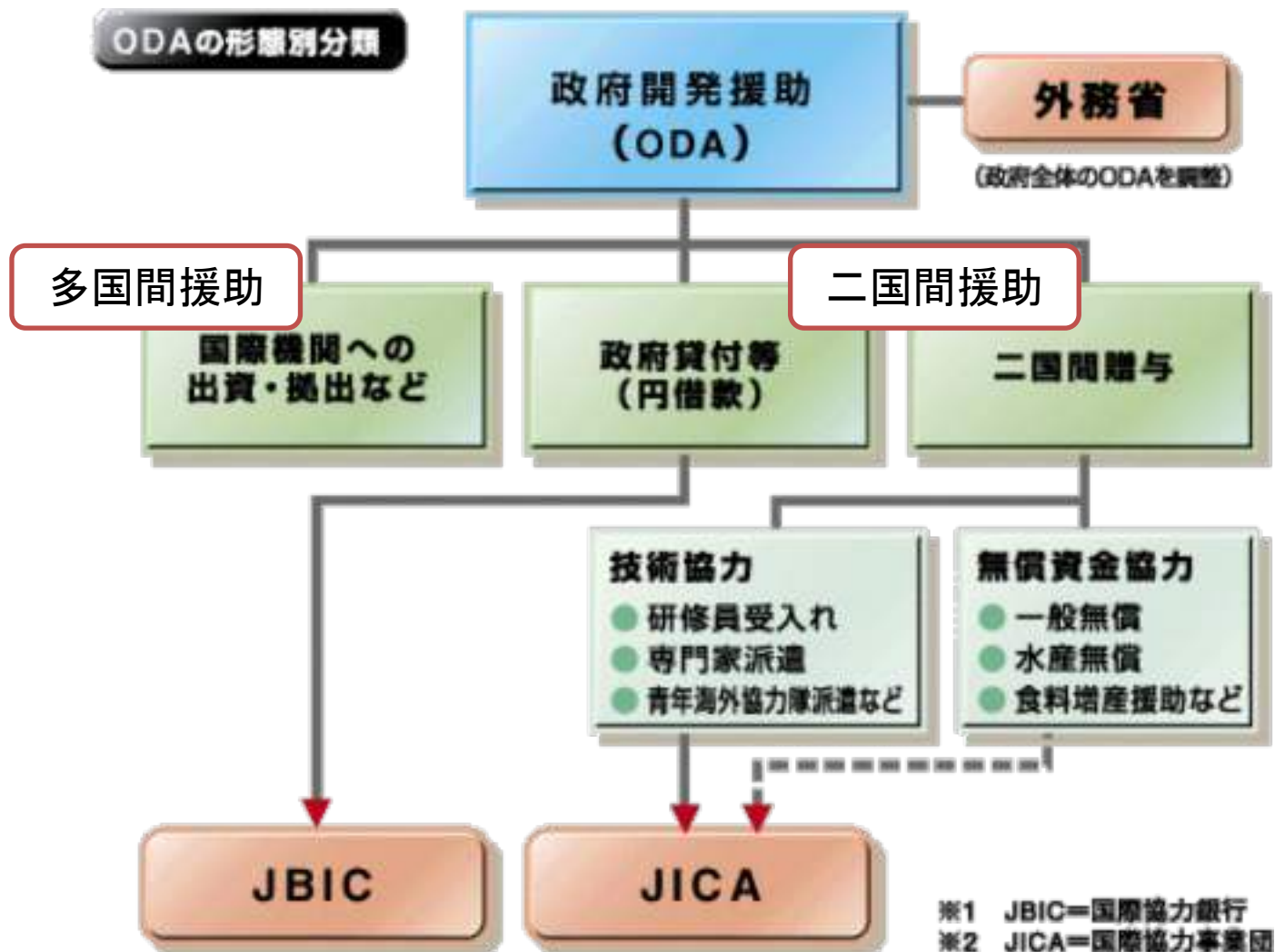
- Official Development Assistance (政府開発援助) の略
- 開発協力とは, 「開発途上地域の開発を主たる目的とする政府及び政府関係機関による国際協力活動」のことで、そのための公的資金をODAという
- 開発途上国に対して直接援助を実施する二国間援助(贈与と貸付)と、国際機関を通じた援助(多国間援助: 国際機関に対する出資や拠出)がある

4つの理念

- 人道的考慮
- 相互依存性の認識
- 環境の保全
- 自助努力の重視



二国間協力機関



非政府組織(NGO)とは

- Non Governmental organizationの略
- 緊急援助、保健医療を含む福祉、開発、環境、人権、平和、調査研究と政策提言等、自主的に活動する非営利の非政府団体のこと
- 行政のサービスや援助の届かない地域の人々に対して活動している

途上国における NGO活動の一例

カンボジア&東チモール 公衆衛生活動

カンボジア 基本情報



面積	18.1万km ² (日本の約2分の1弱)
人口	約1,530万人(2019年)
言語	公用語:カンボジア(クメール)語
宗教	仏教(上座部仏教)90%



カンボジア 基本情報



出生時の平均寿命：

58.7歳(2000年)→70.1歳(2019年)

HIV感染率：0.6%(15-49歳以上、2021年)

乳児死亡率：21人/出生1,000(2021年)

5歳未満児死亡率：

106人/出生1,000(2016年)→25人/出生1,000(2021年)

妊産婦死亡率 218人/出生10万人(2021)

日本



平均寿命：81.5歳(男性)、87.6歳(女性)

乳児死亡率：2人/出生1,000(2021年)← 21人/出生1,000(1964年)

5歳未満児死亡率：2.3人/出生1,000(2020)← 25人/出生1,000(1965)

妊産婦死亡率：2.8人/出生10万人(2021年)

カンボジアでの教育の現状(2023)

義務教育

- 小学校(初等教育): 修了率 68%(男)、79%(女)
- 中学校(前期中等教育): 修了率 41%(男)、39%(女)

義務教育以降

- 高校(後期中等教育): 修了率 20%(男)、20%(女)

世界子ども白書2023 Retrieved from: https://www.unicef.or.jp/sowc/pdf/UNICEF_SOWC_2023_table11.pdf (Accessed on 22 April 2025)

- 大学(高等教育): 就学率 0.7~1.0%(2011年)

学校へ通えない理由

理由1 学校が近くにない

日本には学区があって、近くの学校に通います。しかし、貧しい国や地域では、学校の数が少なく、家からは遠すぎて通えないことがあります。



理由2 先生がいない

先生を育てる仕組みがなかったり、先生に給料を払えなかったりする国や地域があります。また、給料や生活環境の問題から、農村地域に先生が行きたがらないということもあります。



理由3 学校に通うためのお金がない

生活をしていくためのお金すら十分に手に入れることもできないため、授業料や教科書代が払えない人が多いです。



理由4 家計を助けなければならない

家が貧しく、家計を助けるために、子どもでも農業など家の仕事を手伝ったり、外に働きに出なければいけないことがあります。



理由5 弟や妹の世話をしなければならない

両親とも働かなければならないために、子だくさんの家庭では、兄や姉が幼い弟妹の面倒を見なければならないこともあります。



理由6 親が学校に行かせてくれない

子どもを学校に通わせるくらいなら、働かせたほうがまだと考えている親や、女の子に教育は必要ないと考えている親がいます。



理由7 重病にかかった

貧しい国や地域では衛生環境が悪いうえに、栄養状態も悪いために、病気にかかりやすく、近くに病院もないために病気が重くなり、治らない子どもがいます。

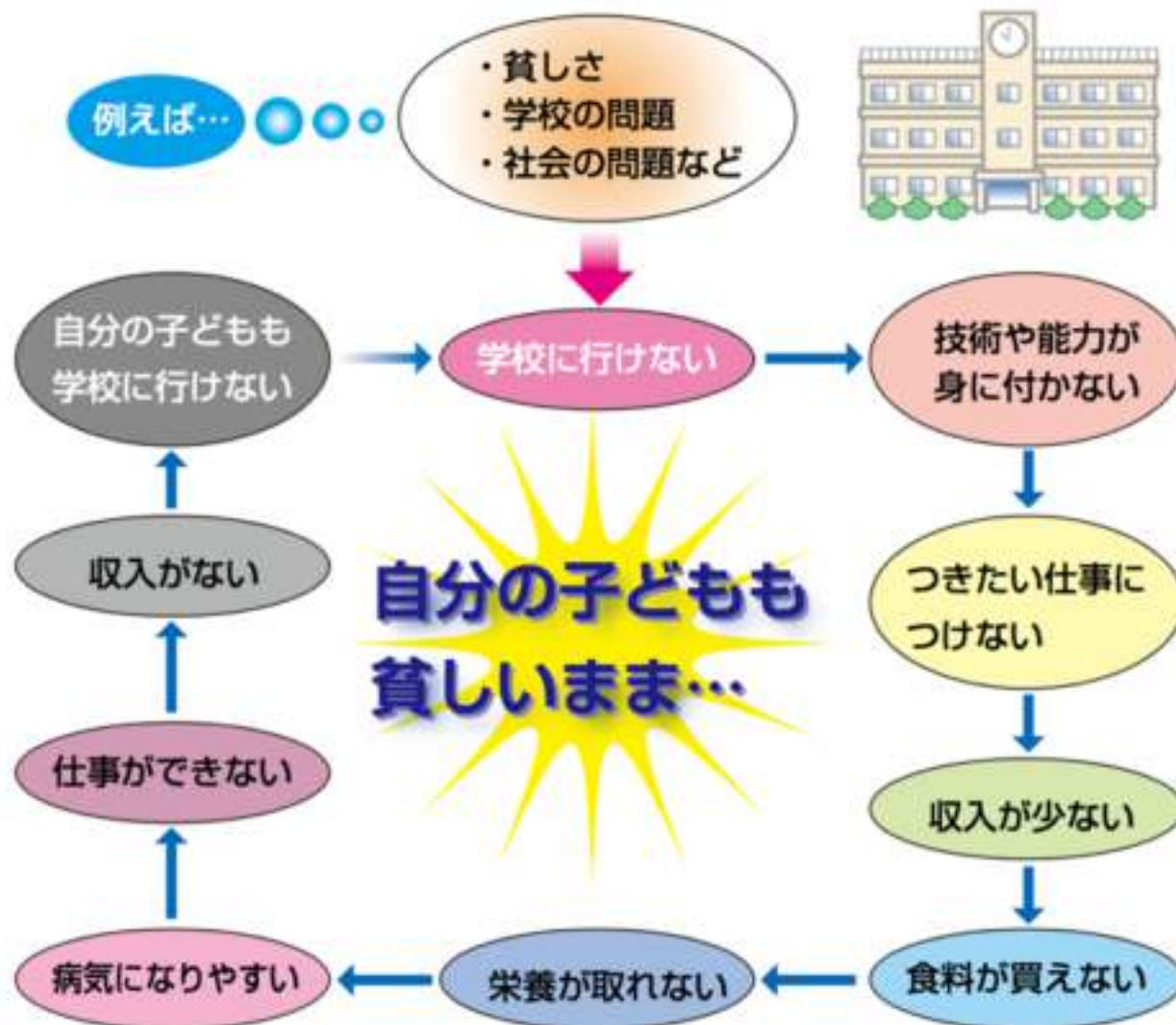


理由8 戦争に巻き込まれた

戦争などで学校が破壊されたり、難民として避難しなければならなかったり、時には少年兵として駆り出されたりする子どもがいます。

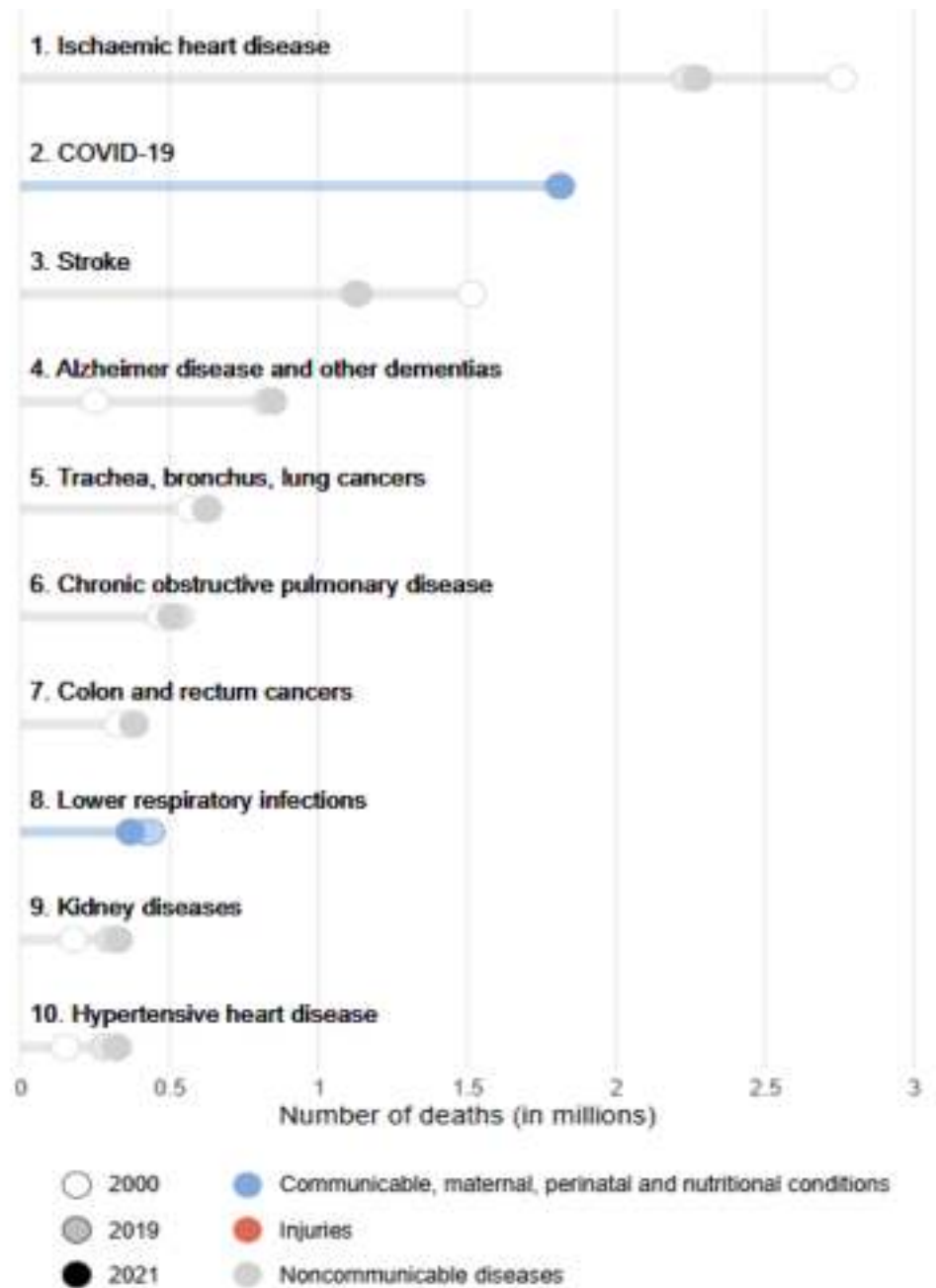


学校へ通えないことで生じる負の連鎖

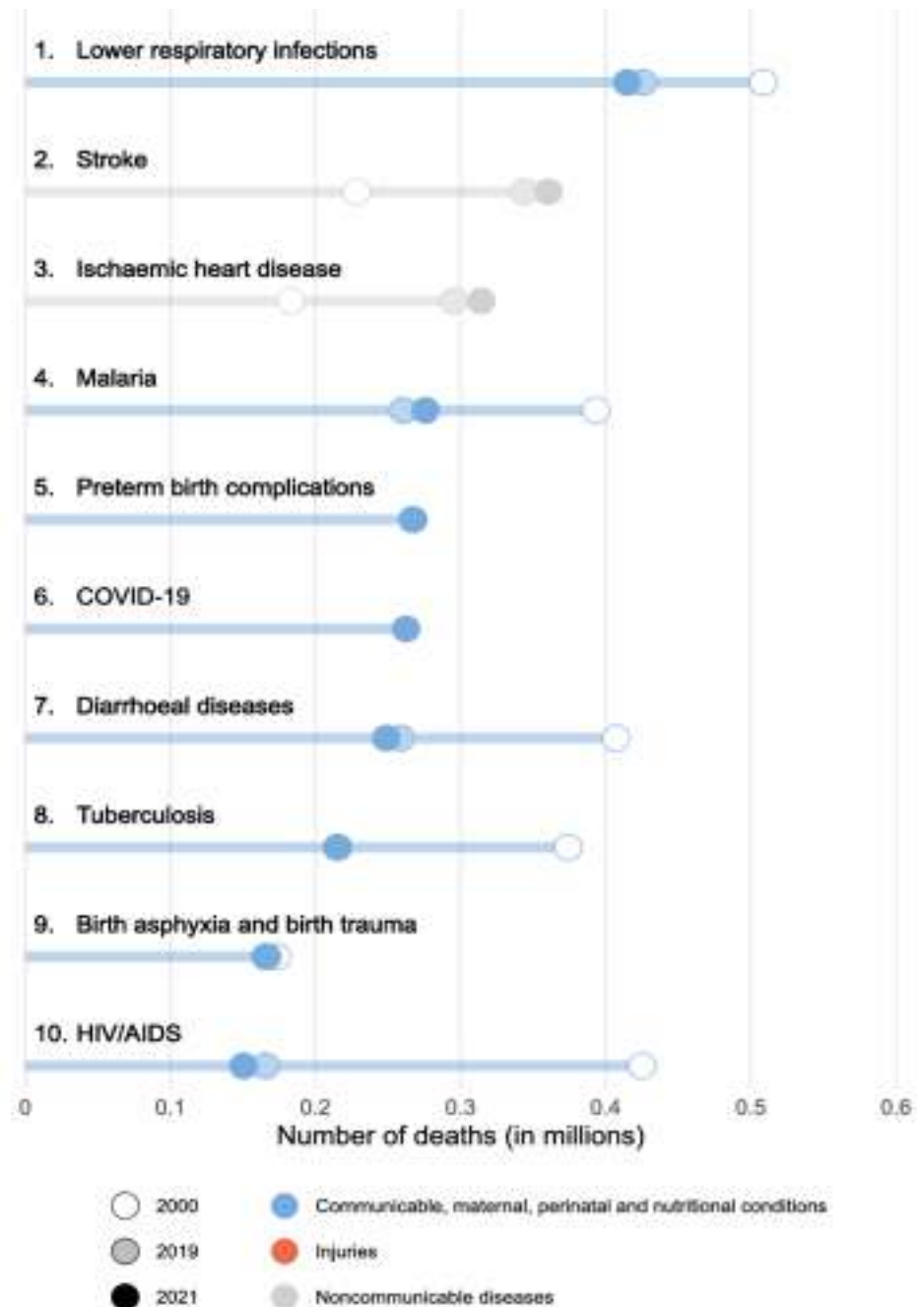


公眾衛生活動

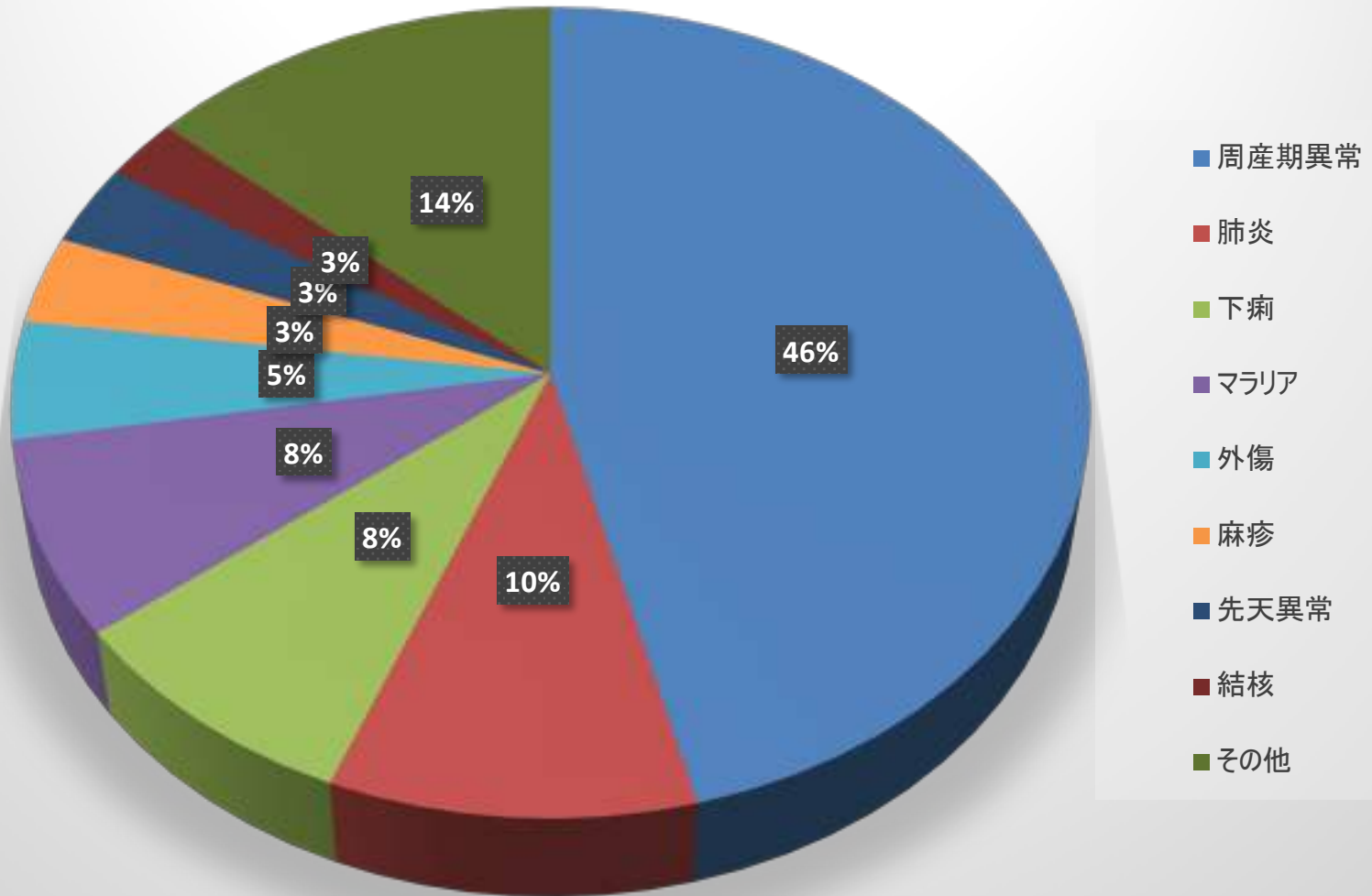
Leading causes of death in 2021 in high-income countries



Leading causes of death in 2021 in low-income countries



世界の5歳未満児死亡死因(2019)



6

安全な水とトイレ
を世界中に



安全な水へ30分以内にアクセス
手洗いの普及
下水道の普及



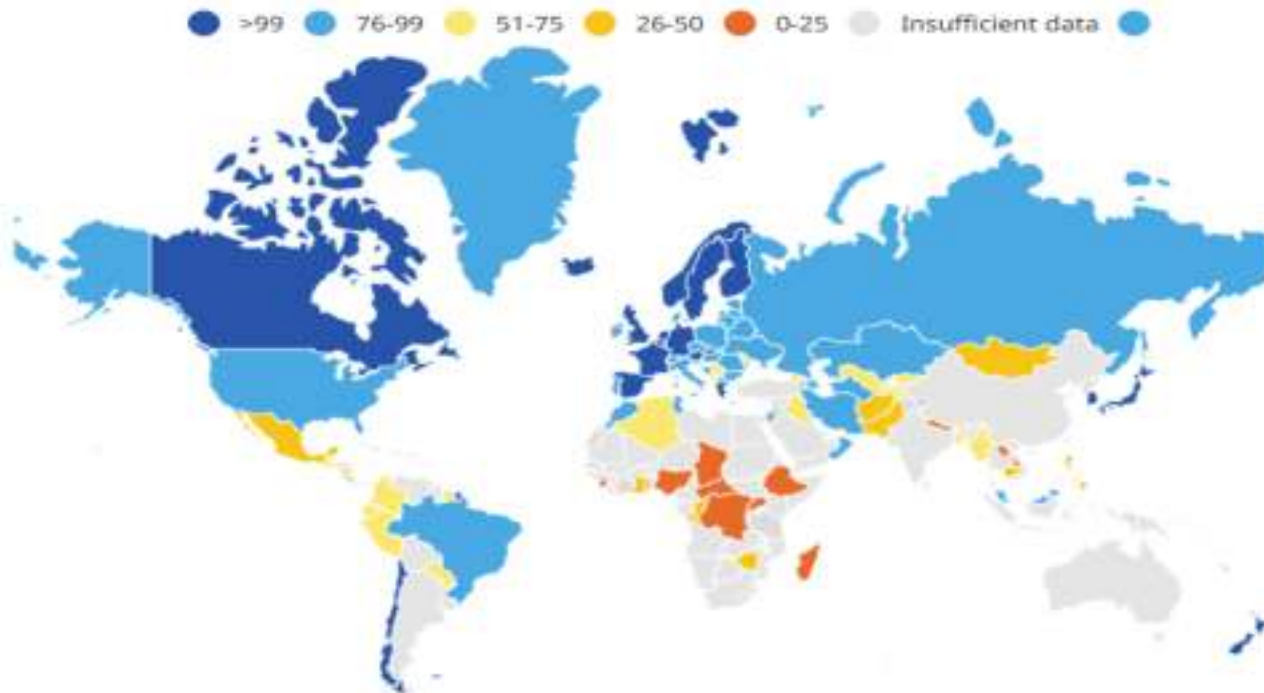
© UNDP Afghanistan

すべての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する

安全な水が使用できる割合

In 2020, 138 countries had estimates for safely managed drinking water

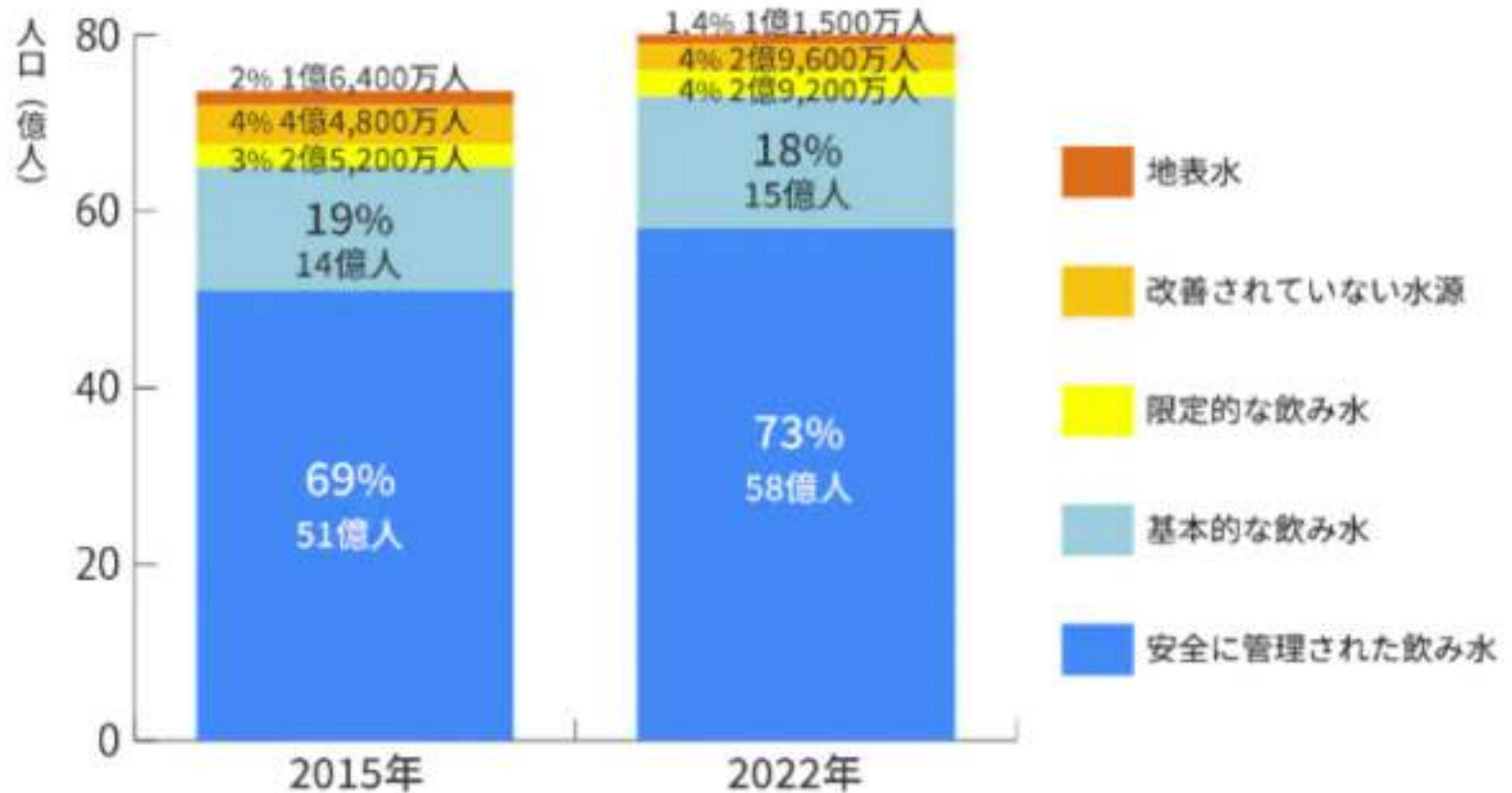
Proportion of population using safely managed drinking water services, 2020 (%)



This map does not reflect a position by UNICEF on the legal status of any country or territory or the delimitation of any frontiers.

Source: WHO/UNICEF JMP (2021), Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2020: Five years into the SDGs

2015年から2022年にかけての成果



現地での公衆衛生教育の例

～下痢～



食べる前に手を洗おう！

水を足すのは、トイレで！
トイレの蓋は閉めてね。

食べ物にはカバーをしよう。

下痢をしたら。。。。

作ろう！

お粥汁で代用できるよ。

The boiled water from cooking rice can be instead of ORS

- Breast milk is the best food for the babies. A poorly nourished child with diarrhea must have enough energy foods and protein.

ORS(Oral Rehydration Solution)

経口補水液

脱水を防ぐ、簡単で安価な治療法である

コップ1杯の水

砂糖スプーン1杯

塩小スプーン半分

現地での公衆衛生教育の例 ～マラリア～



る地域
る地域



when you put them around your bed room, mosquito

東ティモールの生活

東ティモール



- 2009年12月 東ティモール



アジア地域に位置する共和制国家。

1999年8月30日、国連主導の住民投票によりインドネシアの占領から解放され、2002年5月20日独立した。国際法上はポルトガルから独立したことになる。

東ティモール基礎知識

- 国名：東ティモール民主共和国
(The Democratic Republic of Timor-Leste)
- 首都：ディリ
- 人口：110万人(2008年)
- 面積：14,600 km²
- 人口密度：75人/km²(北海道とほぼ同じ)
- 人種：テトゥン族など大半がメラネシア系種族
- 宗教：キリスト教99.1%(カトリックが大半)、イスラム教0.79%
- 通貨：米ドル
- 言語：テトゥン語公用語としてポルトガル語、実用語として
テトゥン語インドネシア語、他に14～16の地域言語がある

主要農作物、工業製品：
米、とうもろこし、コーヒー、石油、天然ガス

合計特殊出生率：6.0人(2000)→3.1人(2021)
5歳未満児死亡率(1000人あたり)：111人(2000)→51人(2021)



出典：SHARE HP <https://share.or.jp> (2020.05.21Access)

21世紀最初の独立国

東ティモール

成人識字率：男性56.3%、女性43.9%

（UNDP2004）

開発途上国の保健医療について 誤っているのはどれか？

1. 成人HIV感染率はサハラ以南アフリカが最も多い
2. 5歳未満死亡率はこの20年で横ばいである
3. 肺炎は5歳未満児の3大死因の一つである
4. 乳児の下痢には母乳の継続が有効である
5. マラリアの予防には蚊帳が有効である

WHOが公表した2019年のファクトシートによれば、
低中所得国よりも高所得国で上位にある死因はどれか？

1. 交通事故
2. 下痢性疾患
3. 下気道感染症
4. 認知症
5. 新生児仮死および出生児損傷

非感染性疾患（脳新血管疾患・悪性新生物・慢性呼吸疾患・糖尿病を含む）の
国際保健における現状について正しいのはどれか？

1. 死亡原因としては感染性疾患より少ない
2. 死亡の半分以上は高所得国で発生している
3. 急速な都市化や生活習慣のグローバル化が加速要因となっている
4. 最大の寄与を有する単一リスクファクターは塩分過剰摂取である
5. 低・中所得国においては、富裕層の方が貧困層より死亡率が高い

学生時代に途上国や異文化に 飛び込むメリットは？



hirokosenda612@gmail.com